La méthode en 4 étapes

FICHE 1 / COMPRENDRE

1 · INDICES

Données brutes observées, mesurées, entendues ou recueillies. Recueil à l'admission et lors de chaque contact. Trier selon la pertinence.

2 · SAVOIRS ET HYPOTHÈSES

Relier les indices à ses connaissances pour envisager une ou plusieurs explications sans conclure trop vite.

3 · INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Questionner, observer, examiner, consulter dossier/équipe/proches selon la situation pour confirmer ou écarter une hypothèse.

4 · JUGEMENT CLINIQUE

Retenir les problèmes de santé réels et potentiels argumentés, les prioriser et les réévaluer.

MÉMO : I → S → C → J = Indices → Savoirs → Contrôle → Jugement.

Recueil de données : MTEVD

FICHE 1 / MÉMORISER

LES 5 RUBRIQUES

Maladies : motif, antécédents, signes. **T**hérapeutiques : traitements, allergies, dispositifs. **E**nvironnement : proches, aides, lieu de vie. **V**écu : ressenti, préoccupations. **D**éveloppement : âge, autonomie, capacités.

OÙ SONT LES INDICES ?

Observation (teint, comportement, respiration) ; paroles et non-verbal ; examen clinique et constantes ; dossier patient ; observations de l'équipe.

NE PAS CONFONDRE

« Le patient dit avoir mal » = donnée ; « douleur actuelle » = hypothèse/problème à étayer par un recueil adapté. Distinguer **faits, hypothèses, conclusions.**

Question rapide : que signifie le V de MTEVD ? → Vécu.

Réel ou potentiel ?

FICHE 2 / COMPARER

PROBLÈME RÉEL

Déjà présent : signes objectifs (mesurés/observés) ou subjectifs (exprimés). Ex. douleur 6/10 décrite ; nausées signalées.

PROBLÈME POTENTIEL

Risque non encore survenu, favorisé par des facteurs individuels, environnementaux ou liés aux soins. Ex. chute liée à instabilité et obstacle.

QUESTIONS À POSER

Réel : quels signes le démontrent ? Potentiel : quels facteurs rendent le risque probable, et quels signes indiqueraient qu'il est devenu réel ?

ATTITUDE IDE / ESI

Surveiller, prévenir, hiérarchiser. Rechercher les données manquantes, transmettre les signes nouveaux et alerter si aggravation.

À retenir : « risque de chute » n'est pas une « chute » constatée.

Le modèle trifocal

FICHE 2 / 3 DOMAINES DU COURS

DOMAINE 1 · MÉDICAL

Pathologies diagnostiquées ou suspectées, signes/symptômes, complications de la maladie ou du traitement. Ex. infection diagnostiquée.

DOMAINE 2 · RISQUES

Problèmes potentiels liés à la pathologie, aux traitements, aux réactions humaines. Ex. risque d'altération cutanée.

DOMAINE 3 · RÉACTIONS HUMAINES

Réponses physiques et psychologiques. Ex. douleur, anxiété, sommeil perturbé.

DEUX RAISONNEMENTS

Anticipation : prévoir et prévenir. **Inducto-hypothético-déductif** : indices → hypothèses → recherche → conclusion. Ils fonctionnent ensemble.

Piège : le jugement clinique n'est pas la même chose qu'un diagnostic médical.

Le tableau RCP et le stage

FICHE 3 / APPLIQUER

RCP = RAISONNEMENT CLINIQUE PARTAGÉ

Les 5 colonnes du support : **Indices** | **Savoirs mobilisés** | **Hypothèses** | **Éléments à rechercher** | **Sources d'information**.

EXEMPLE

Indice : marche instable. Savoir : facteur de chute. Hypothèse : risque de chute. À rechercher : antécédents, vertiges, traitements, obstacles. Sources : patient, observation, dossier, IDE.

SURVEILLER / TRANSMETTRE

Noter les faits, paramètres adaptés, paroles exactes, heure, évolution ; évaluer après intervention. Alerter l'IDE si signes de gravité ou dégradation.

En stage : observer → demander à l'IDE → agir sous encadrement → réévaluer.

Partiels · mini-quiz corrigé

FICHE 3 / AUTOÉVALUATION

QUESTIONS 1 À 3

1. Les 4 étapes ? **2.** Différence réel/potentiel ? **3.** Que signifie MTEVD ?

QUESTIONS 4 À 6

4. Les 5 colonnes RCP ? **5.** Domaine trifocal du risque de chute ? **6.** 2 types de raisonnement ?

CORRIGÉ

1. Indices → Savoirs/hypothèses → Informations complémentaires → Jugement. **2.** Présent / risque futur. **3.** Maladies, Thérapeutiques, Environnement, Vécu, Développement. **4.** Indices, Savoirs, Hypothèses, À rechercher, Sources. **5.** Domaine 2. **6.** Anticipation et inducto-hypothético-déductif.

Référence : arrêté IDE du 20 février 2026, domaine A / UE A1. Aucun page tête-bêche.